

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012			
			VERSIÓN: 001	PAGINA: 01	DE: 01	
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		FECHA DE EMISIÓN:			
		DÍA: 9 MES: 09 AÑO: 2024				
Nombre del equipo:	Monitor fetal	Modelo:	F3	Riesgo del equipo:		I
Marca:	EDAN			Clasificación del equipo:		Diagnóstico
DEFINICIÓN DE USO DEL EQUIPO		PARTES DEL EQUIPO		TECLA Y PERILLA DE CONTROL		
 Está diseñado para el monitoreo no invasivo e invasivo del feto durante el examen prenatal, el trabajo de parto y el parto. Está diseñado para ser utilizado únicamente por personal capacitado y calificado en salas de examen prenatal, de trabajo de parto y de parto. El monitor proporciona pruebas sin estrés para mujeres embarazadas a partir de los 28 años.		 - Indicador de alarma - pantallas LCD - claves - Perilla de control - Cajones de papel - tomas para accesorios - Interruptor de encendido - Indicadores - Pestillo para cajón de papel		 Interruptor: Funcion de encendido y apagado del monitor. Tecla de START (INICIO): Iniciar el monitoreo Tecla de SILENCE (SILENCIO): Presione esta tecla para encender o apagar el sonido de la alarma. Tecla de AUTO ZERO (CERO AUTOMÁTICO): Ajusta el trazo/valor de las contracciones de TOCO externo para predefinir la unidad. Tecla de MARK (MARCA): Presione esta tecla para realizar una marca de un evento. Tecla de PRINT (IMPRESIÓN): Presione esta tecla para alternar entre iniciar y detener impresión. Tecla de CHANNEL (CANAL): Al presionar esta tecla, los latidos fetales alternan entre el canal US1 y el canal US2. Perilla de control: Todas las funciones en la pantalla o el menú se realizan mediante la perilla de control.		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dimensiones: 350mm x 300mm x 104mm. Peso: Aproximadamente 3.5kg. Ultrasonido: Técnica: Doppler pulsado con correlación automática. Repetición de Pulso: 2 KHz. Duración de pulso: 92 us. Frecuencia: 1.0 MHz $\pm$ 10% Rango de medición FCF: 50 lpm - 240 lpm. Re solución FCF: 1 bpm.		 - Toma de corriente - Equipotencial Terminal de puesta a tierra - Conectores DB9 - Conectores RJ45 - Tomas USB		MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO Monitoreo de la FHR con ultrasonido: Es un método que se utiliza para obtener la frecuencia cardíaca fetal en la pared abdominal materna. Coloque el transductor de ultrasonido sobre el abdomen materno. Transmite una onda de ultrasonido de baja potencia al corazón del feto y recibe una señal de eco. Monitoreo de AFM: En este el movimiento del feto se detecta y se puede visualizar en forma de trazo en la pantalla y en el papel de registro. Monitoreo de MFM: El resultado de los movimientos fetales manuales (MFM) se observa cuando la paciente siente los movimientos fetales. La cantidad se visualiza en la pantalla en el área de datos numéricos de los movimientos fetales manuales (MFM).		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN La limpieza y desinfección se realiza con el producto que se está utilizando actualmente en la institución, en tal caso, de que no haya disponibilidad, utilizar alcohol al 70%. NOTA: A fin de evitar infecciones, limpie y desinfecte el monitor y los accesorios después de cada uso.						
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:						
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.						
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica						
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo						
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.						
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.						
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas						
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.						

	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E		CODIGO: FOR-GLO-MAB-012		
	FORMATO GUÍAS RAPIDAS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS		VERSIÓN: 001	PAGINA 01 DE 01	
			FECHA DE EMISIÓN:	DÍA 9 MES 09 AÑO 2024	
Nombre del equipo:	Monitor fetal	Modelo:	F3	Riesgo del equipo:	I
Marca:	EDAN			Clasificación del equipo:	Diagnóstico
AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA PANTALLA		ALARMAS Y POSIBLES ERRORES		ENCENDIDO	
Puede plegar la pantalla completamente o inclinarla a un ángulo apropiado, lo que permite colocar el monitor sobre una superficie plana o montarlo en una pared. Para inclinar o plegar la pantalla. 1. Empuje el gancho en la parte superior de la pantalla hacia la derecha para abrirla. 2. Sostenga la parte central de la pantalla por el borde superior y empujela hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar el ángulo requerido. 		1. Batería baja: La carga de la batería es demasiado baja para permitir que el monitor siga funcionando. Conecte el monitor a la fuente de alimentación de CA. 2. US1 desenchufado o US2 desconectado: Transductor 1 ó 2 no está conectado. Mira la conexión. 3. Pérdida de señal US1 ó US2: La señal FHR1 o FHR2 es demasiado débil para que el sistema la analice. Verifique si el transductor ecográfico está apuntando al corazón fetal. 4. Papel de cheque: No hay papel en el cajón de papel o el cajón está abierto. Cargue papel y/o cierre el cajón. 5. DECG lidera: El electrodo espiral no está bien conectado. Verifique la conexión del electrodo espiral. 6. DECG desconectado: El cable DECG no está bien conectado al monitor. Verifique la conexión del cable DECG. 7. Pérdida de señal DECG: La señal DECG es demasiado débil para que el sistema la analice. Verifique que el electrodo espiral esté bien adherido al feto; verifique el estado de la mujer.		Presione el interruptor:  En el panel frontal se enciende el monitor. El indicador de encendido se iluminará y se escuchará una música de inicio. Puede operar el monitor después de que aparezca la interfaz principal.	
CONEXIÓN DE TRANSDUCTORES		GUARDAR DATOS		APAGADO	
Compruebe siempre que los transductores no presenten daños visibles antes de conectarlos al monitor. Preste especial atención a las grietas en los transductores y cables antes de sumergirlos en un líquido conductor. Si encuentra daños, reemplácelos inmediatamente por otros en buen estado. Al conectar los transductores al monitor, asegúrese de que los símbolos de flecha del conector estén orientados hacia arriba.  Conexión del transductor Desconexión del transductor Al desconectar un transductor, presione la parte posterior del enchufe del transductor y tire de él con cuidado.		El monitor guarda automáticamente los datos cada dos minutos y antes de apagarse, incluidos los registros de monitoreo fetal y la información materna. La capacidad máxima es de 60 horas de datos. Al encender nuevamente el monitor, se cargarán esos datos. Podrás revisarlos o imprimirlos a alta velocidad.		Presione el interruptor:  Mantener pulsado durante al menos 1 segundo para apagar el monitor. Después de apagar el monitor, espere al menos 10 segundos antes de encenderlo nuevamente.	
PASOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO					
Inicio de monitoreo: -Una vez que presiona la tecla START el monitor comienza automáticamente un nuevo monitoreo después de completar las siguientes operaciones: Detiene la impresión de datos del último monitoreo, verifica la conexión del transductor, borra la cantidad de movimientos fetales manuales (MFM) y el temporizador de monitoreo y pone a cero la presión. Un símbolo de inicio se observa en la pantalla. -Si la impresión de inicio automático está desactivada, presione la tecla PRINT para comenzar a imprimir. -Después de presionar la tecla de START, el sistema crea una identificación (ID) automática para el nuevo paciente.					
El diligenciamiento de este formato se realizará de la siguiente manera:					
1. Definición de uso del equipo: En este campo se ingresará la definición detallada del uso del equipo desde el concepto del fabricante o el registro Invima.					
2. Especificaciones técnicas: En este caso se describirá detalladamente la ficha técnica del equipo, donde se describan las características del mismo y condiciones especiales si aplica					
3. Partes del equipo: Se ilustrará y se enumerará las partes del equipo y el modo de operación de cada una, incluyendo accesorios y consumibles del mismo					
4. Modos de operación del equipo: En este caso, se describirá el modo de operación o funcionamiento del equipo y como utilizar cada uno de ellos.					
5. Limpieza y desinfección: En este apartado se describirá la limpieza y desinfección recomendada por el fabricante del equipo.					
6. Alarmas y posibles errores: Se describirá de manera resumida las posibles alarmas o errores de interfaz que se puedan presentar en el equipo de manera común y como solucionarlas					
7. Pasos de operación del equipo: Indicar de manera detallada los pasos de operación del equipo, en donde se incluya las acciones que se deben ejecutar de manera inicial y final para el funcionamiento del mismo.					